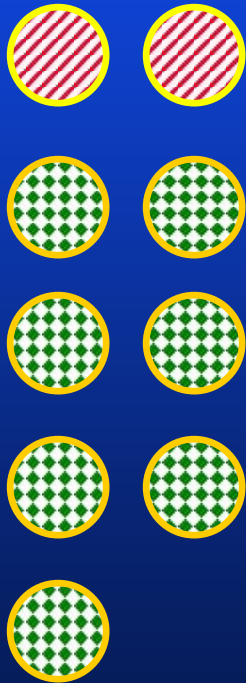


Un patient arrive avec une anémie hémolytique, vous observez classiquement:

1. Un rapport médullaire M/E (précurseurs myéloïdes/ précurseurs érythroïdes) augmenté.
2. Un taux sanguin de LDH augmenté.
3. Un compte réticulocytaire diminué.
4. Un taux sanguin de bilirubine conjuguée augmenté.
5. Une microcytose.

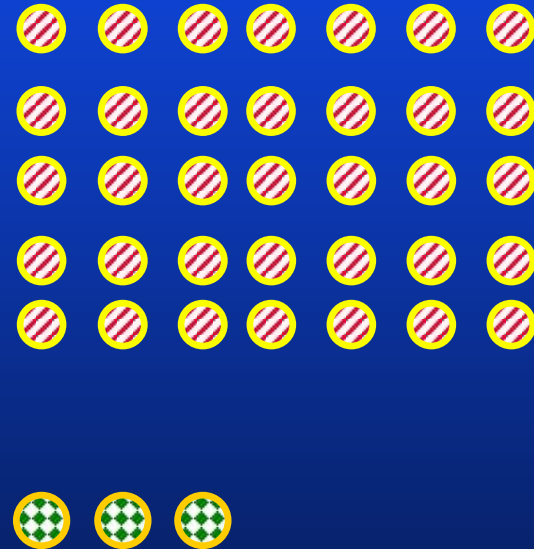
Réaction médullaire - introduction

Moelle hématopoïétique



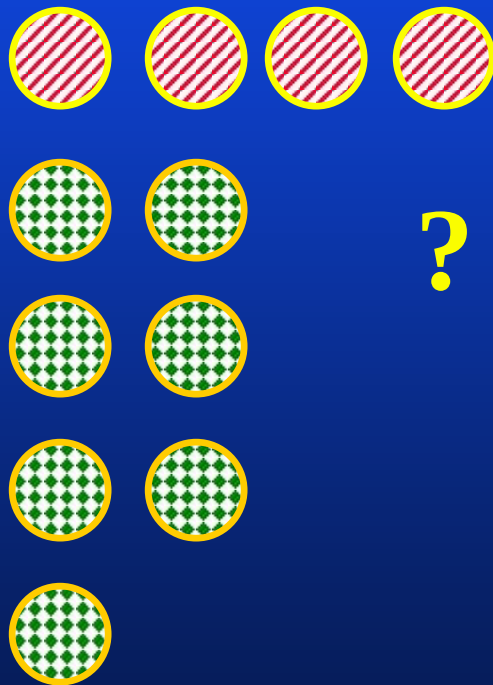
Rapport M/E : 3-4/1

Sang périphérique



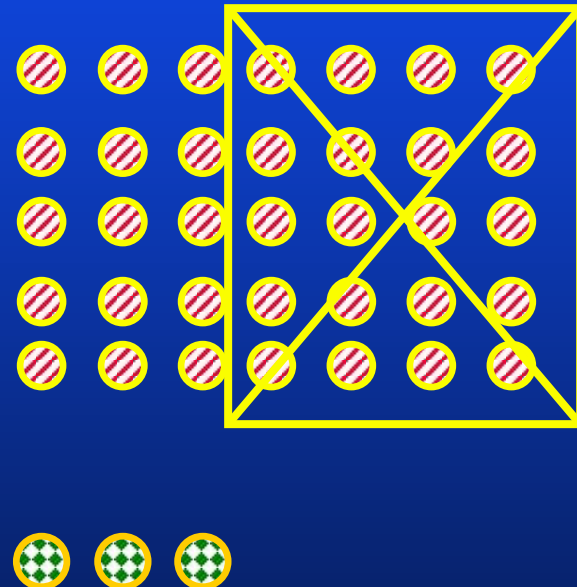
Réaction médullaire – anémie d'origine périphérique

Moelle hématopoïétique



Rapport M/E : 7/4↓()

Sang périphérique



Réticulocytes > 120 G/l

Un patient anémique se présente à la consultation, vous découvrez une gammopathie monoclonale IgM kappa avec des taux d'IgM sériques normaux, vous orientez votre recherche en premier vers:

1. Une infection virale aiguë
2. Un lymphome de haut degré de malignité
3. Une amyloïdose
4. Un syndrome de « POEMS »
5. Une Leucémie lymphoïde chronique et un lymphome lymphoplasmocytaire

Gammopathie monoclonales: nosologie

- MGUS
- Hémopathies malignes
 - IgG: Myélome – Plasmocytome
 - IgM: Syndrome lymphoprolifératif (lymphome malin)
 - » Leucémie lymphoïde chronique
 - » Maladie de Waldenström (lymphome lymphoplasmocytaire)
- Amyloïdose
 - Souvent lambda
- Syndrome de POEMS
 - Souvent IgG/IgA et lambda

**Un patient est hospitalisé pour une asthénie en relation avec une anémie, une insuffisance rénale, et une hypercalcémie.
Vous recherchez principalement:**

1. Un purpura thrombocytopénique thrombotique (Moschowitz).
2. Une coagulation intravasculaire disséminée sur un cancer du tube digestif.
3. Un myélome multiple.
4. Une infection à virus Epstein-Barr.
5. Une carence en acide folique

Atteintes d'organes par MM

- Hypercalcémie et hyperuricémie
- Insuffisance rénale
- Anémie
- Lésions osseuses
 - Fractures
 - Compressions radiculaires et médullaires)
- Autres atteintes:
 - Hyperviscosité sanguine (paraprotéine plasmatique)
 - Infections
 - Amyloïdose
 - POEMS

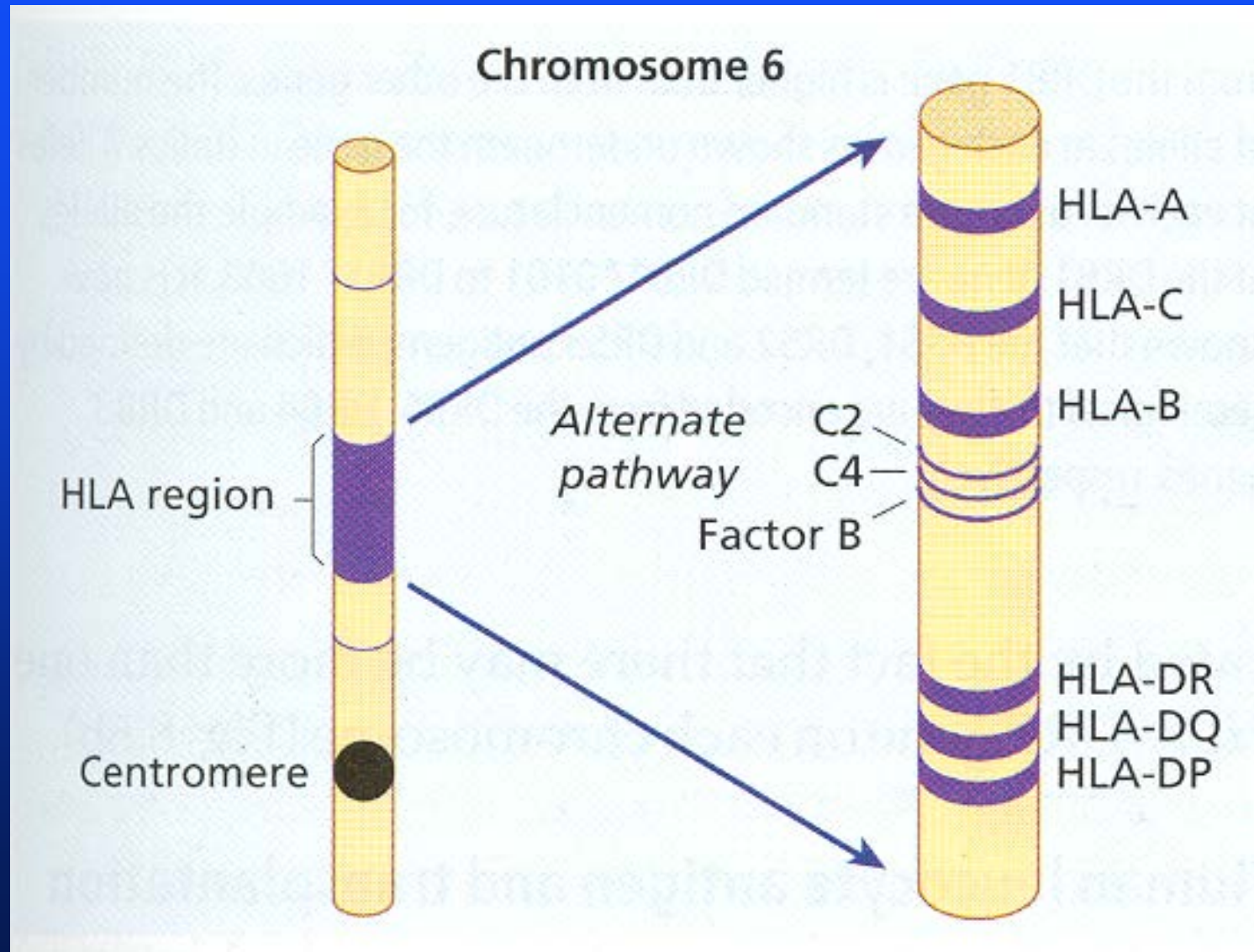
Un patient arrive aux urgences 7 jours après un accident nucléaire. Il s'est fait irradier le corps entier à une dose toxique pour la moelle hématopoïétique mais pas les autres tissus. Il est en bon état général et la formule sanguine périphérique (FSP) suivante est la plus compatible:

1. La FSP est normale, sans anémie ni thrombopénie ni leucopénie.
2. La FSP montre une anémie normocytaire sans leucopénie ni thrombopénie.
3. La FSP montre une leucopénie, une thrombopénie sans anémie et dans ce cadre les réticulocytes sont bas.
4. La FSP montre une lymphopénie sélective sans autres anomalies.
5. La FSP montre une leucopénie sans thrombopénie ni anémie.

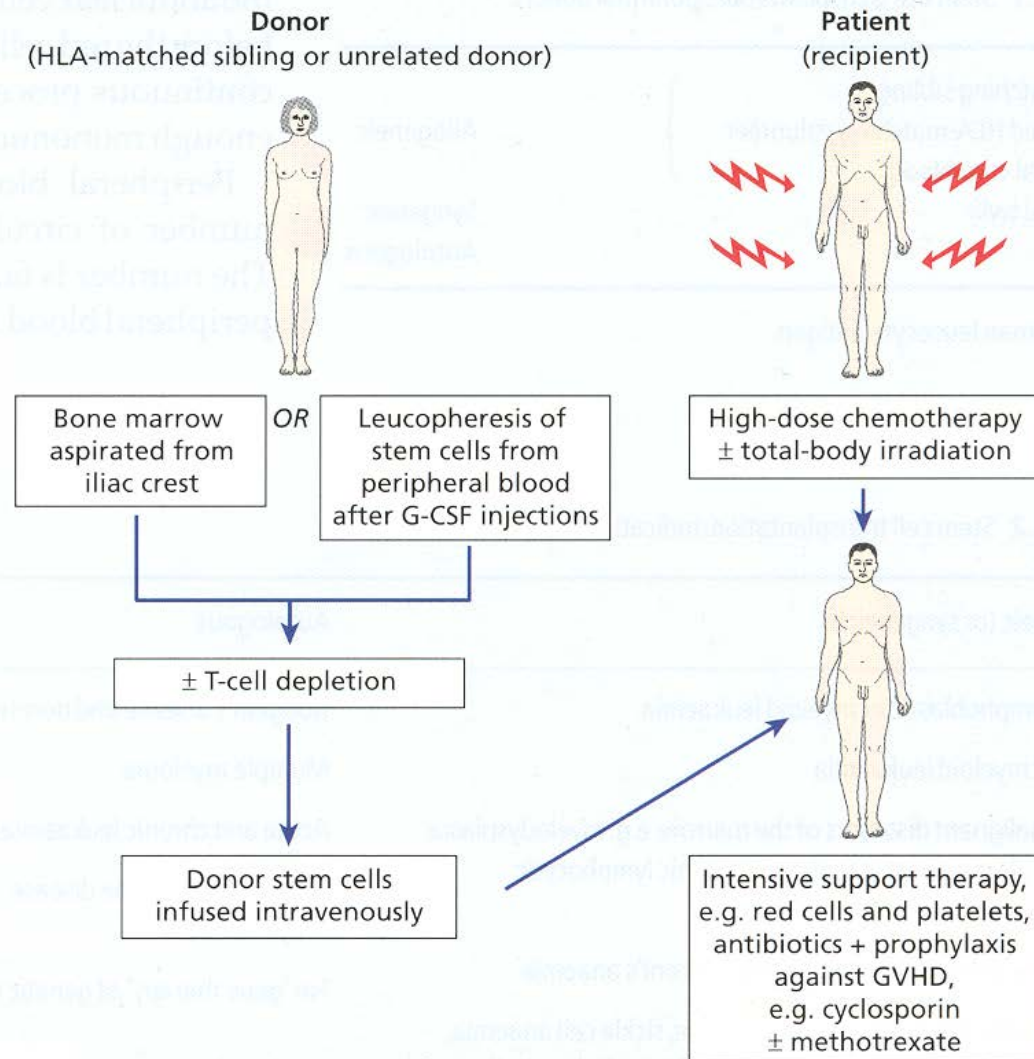
Un patient de 30 ans présente une leucémie myéloïde aiguë avec facteurs de mauvais pronostic. Laquelle des procédures/traitements suivants est la mieux appropriée:

1. Une chimiothérapie intensive en milieu hospitalier pour prévenir les infections.
2. Une allogreffe d'emblée de cellules souches hématopoïétiques à partir d'un donneur non-apparenté sans chimiothérapie préalable.
3. Une autogreffe de cellules souches hématopoïétiques.
4. Une série de chimiothérapies intensives suivies d'une allogreffe de cellules souches hématopoïétiques.
5. Une allogreffe seule de cellules souches hématopoïétiques provenant de son père ou de sa mère.

Complexe majeur d'histocompatibilité



Transplantation allogénique de cellules souches hématopoïétiques



Allogreffes: indications 1

Maladies tumorales:

- Leucémie myéloïde chronique: curatif
- Leucémie myéloïde aiguë: curatif
- Syndrome myélodysplasique: curatif
- Leucémie lymphoblastique aiguë: curatif
- Lymphomes: probablement curatif dans certains cas, mais mortalité trop élevée en comparaison avec les autogreffes

Allogreffes: indications 2

Maladies non tumorales: (remplacement du système sanguin)

- Acquise
 - Anémie aplastique
- Congénitale:
 - Hémoglobinopathies sévères: thalassémie, anémie falciforme
 - Déficit immunitaires congénitaux: p.ex SCID, ADA

Comparaison allogreffe/autogreffe

	Allogreffe	Autogreffe
Age limite	45-55 ans	65-70 ans
Difficultés principales	- Obtenir un donneur HLA-compatible - Toxicité	Contamination du greffon ?
Complication principale	GVH	Récidive
Indication tumorale	Oui	Oui
Indication non tumorale	Maladies génétiques et immunologiques	Non

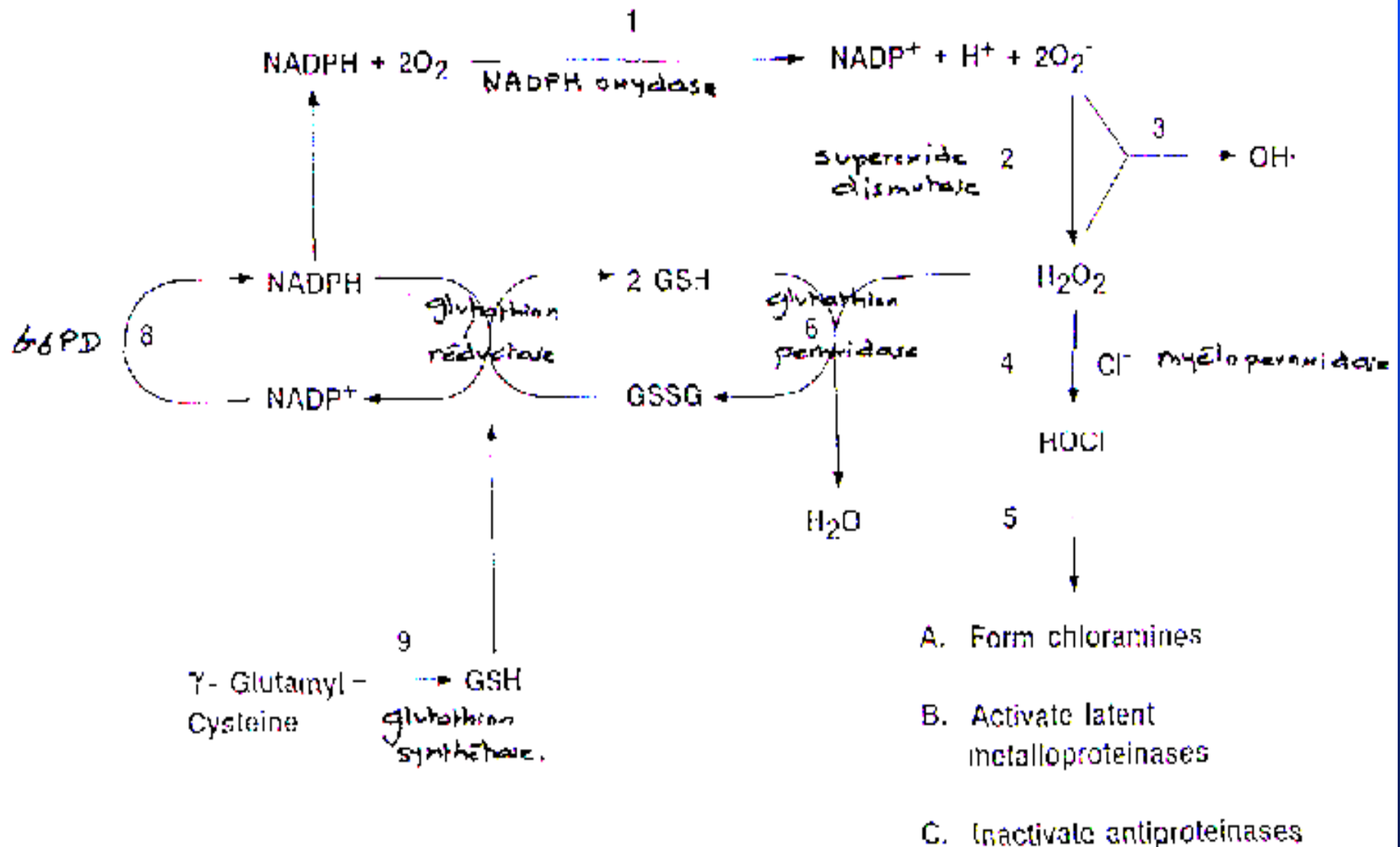
Indication des greffes de moelle en fonction des tumeurs

	Premier choix	Potentiel curatif	Traitement standard
LMC	Allogreffe	Oui	Oui
LMA	Allogreffe	Oui	Oui
LLA	Allogreffe	Oui	Oui
Lymphomes	Autogreffe	Oui	Oui
Myélomes	Autogreffe	Non	Oui
Cancer du sein	?	?	Non
Ca testiculaire	Autogreffe	Oui	Oui

Un enfant se présente à la consultation en raison d'infections sévères récidivantes. Lequel des défauts suivants est compatible avec la clinique:

1. Une déficience totale en myéloperoxydase
2. Une déficience en glucose-6-phosphate dehydrogénase
3. Une déficience en NADPH oxydase
4. Une déficience en céruléoplasmine
5. Une déficience en lactase

« Respiratory burst »



Maladie granulomateuse chronique

- Désordre fonctionnel et congénital.
- Neutrophiles, monocytes, macrophages, éosinophiles incapables de « respiratory burst ».
- Défaut d'activation ou d'activité de la NADPH oxydase (enzyme complexe, multiples sous-unités catalytiques et régulatrices).
- Clinique: Infections bactériennes (organismes catalase +) et fongiques récurrentes dès la première année de vie.
- Examen diagnostique:
 - Réduction du Nitro-Bleu de Tetrazolium
 - Consommation d'O₂

Déficiência en myéloperoxidase

- L'anomalie la plus fréquente parmi les défauts congénitaux fonctionnels des neutrophiles
- Piège: SOUVENT ASYMPTOMATIQUE